

CAPÍTULO 8.20

Cuerpo Extraño Digestivo

PERFIL EUNACOM 1.06.2.005
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diarrea en Pediatría y Alergia a Proteína de Leche de Vaca

Diarrea Aguda

Recordatorio rápido. Ver artículo completo en **Diarrea Aguda y Crónica**.

Planes de Hidratación

TABLA 8.20.1: PLAN VS INDICACIÓN

PLAN	INDICACIÓN	TRATAMIENTO
A	Deshidratación leve (< 5% peso) o sin signos	Sales de rehidratación oral (SRO) 100–200 mL post deposición
B	Deshidratación moderada (5–10% peso, con signos)	SRO 50–100 mL/kg en 4–6 h; fraccionar si vómitos
C	Deshidratación severa (> 10%) o shock	SF EV 20 mL/kg en bolo; vía intraósea si no hay acceso venoso

Indicaciones de hidratación EV (plan C o similar)

- Vómitos incoercibles que impiden la vía oral
- Compromiso de conciencia
- Íleo paralítico o silencio abdominal

Antibióticos en diarrea aguda pediátrica

TABLA 8.20.2: INDICACIÓN VS ANTIBIÓTICO

INDICACIÓN	ANTIBIÓTICO
Shigella o E. coli entero-invasora (disentería + fiebre alta + mal estado general)	Ciprofloxacino VO (excepción a la regla de no quinolonas en niños)
Sepsis/compromiso sistémico grave	Cefotaximo EV
Salmonella no complicada	No antibióticos (prolonga el estado portador)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Antidiarreicos NUNCA en diarrea aguda. Pueden enmascarar y agravar complicaciones bacterianas.

Diarrea Crónica en Pediatría

Causas más frecuentes

TABLA 8.20.3: CAUSA VS EDAD TÍPICA

CAUSA	EDAD TÍPICA	CLAVES
Diarrea crónica inespecífica	Lactante/preescolar	Jugos hiperosmolares → diarrea osmótica; examen físico normal; buen peso
Giardiasis	Preescolar/escolar	Zona rural, flatulencia, dolor cólico, puede haber síndrome de malabsorción
Enfermedad celíaca	Desde 1 año	Sínd. malabsorción + anemia ferropénica + anticuerpos antitransglutaminasa
Fibrosis quística	Desde lactante	Diarrea + neumonías recurrentes (Pseudomonas/Staph)
Alergia a proteína de leche de vaca	Lactante	Diarrea + síntomas alérgicos + reflujo + hemorragia digestiva

Diarrea Crónica Inespecífica

- **Causa:** jugos azucarados/hiperosmolares
- **Clínica:** diarrea crónica intermitente en lactante que por lo demás está bien (crece bien, activo)
- **Diagnóstico:** clínico
- **Tratamiento:** **suspender los jugos** + educar (los jugos son la causa)

Giardiasis

- **Agente:** Giardia lamblia (protozoo unicelular)
- **Contexto:** preescolar/escolar + zonas rurales o higiene deficiente; también en inmunocomprometidos
- **Clínica:** diarrea crónica + flatulencia + distensión abdominal + dolor tipo cólico
- **A veces:** síndrome de malabsorción (esteatorrea, alimentos sin digerir)
- **Si todos en la familia tienen los mismos síntomas** → pensar fuertemente en Giardia
- **Diagnóstico:** parasitológico de deposiciones (3 muestras en días distintos)
- **Tratamiento:** tinidazol (o metronidazol)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Giardia puede producir un cuadro igual a enfermedad celíaca (malabsorción). **Siempre descartar Giardia antes de diagnosticar celíaca.**

Enfermedad Celíaca (Recuerdo)

- **Inicio:** al año de edad (cuando ingresa el gluten)
- **Cereales culpables:** trigo, cebada, centeno (y avena por proteína similar)
- **Diagnóstico:**
 - 1. Anticuerpos anti-transglutaminasa tisular + anti-endomisio
 - 2. Biopsia de duodeno (endoscopia alta): atrofia de vellosidades
- **Tratamiento:** dieta sin gluten de por vida
- **Seguimiento:** anticuerpos deben negativizarse con buena adherencia

Fibrosis Quística (Recuerdo)

- **Genética:** autosómica recesiva → no siempre antecedentes familiares
- **Clínica bimodal:**
 - 1. Síndrome de malabsorción (insuficiencia pancreática exocrina)
 - 2. Neumonías bacterianas recurrentes (Pseudomonas aeruginosa, S. aureus) + bronquiectasias
- **Diagnóstico: test del sudor** (cloro en sudor)
 - - < 40 mmol/L → normal
 - - 40–59 mmol/L → indeterminado → test genético
 - - ≥ 60 mmol/L → **Fibrosis quística confirmada**
- **Tratamiento:** soporte multidisciplinario + enzimas pancreáticas VO + trasplante de pulmón (único que mejora la sobrevida)

Alergia a la Proteína de Leche de Vaca (APLV)

- **Prevalencia:** hasta 4% de los lactantes
- **Mecanismo:** hipersensibilidad tipo II-III (Gell y Coombs)
- **Clínica:**
 - - Síntomas **gastrointestinales** (más frecuentes): diarrea crónica, reflujo, hemorragia digestiva, lesiones perianales
 - - Síntomas alérgicos: exantema, asma, rinitis
- **Afecta a lactantes con fórmula** (principal) y también a los con lactancia materna (la madre pasa proteínas)

Diagnóstico

- **Prueba terapéutica:**
- Cambiar a fórmula hidrolizada (o suspender lácteos en la madre si lactancia materna)
- Observar 4 semanas → si mejora → **reintroducir** la leche de vaca
- Si síntomas reaparecen al reintroducir → **diagnóstico confirmado**

Tratamiento

TABLA 8.20.4: TIPO DE ALIMENTACIÓN VS CONDUCTA	
TIPO DE ALIMENTACIÓN	CONDUCTA
Fórmula	Cambiar a fórmula hidrolizada extensamente o amino-ácidos
Lactancia materna	Madre sigue con lactancia + dieta sin lácteos

EUNACOM CRITERIOS

El diagnóstico de APLV se confirma con: 1. Mejoría al suprimir 2. Recaída al reintroducir
No hay test sangriento validado específico → la prueba terapéutica es el estándar.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 14 meses es llevado a urgencias por sus padres tras haber ingerido accidentalmente una pila de botón de 20 mm hace 1 hora. La radiografía de tórax y abdomen muestra imagen radiopaca redondeada de doble contorno en el tercio medio del esófago."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Cuerpo Extraño Esofágico (Pila de Botón): la presencia de una pila de botón impactada en el esófago genera necrosis por licuefacción, perforación esofágica y fístula aortoesofágica exanguinante en menos de 2 horas por generación de corriente eléctrica e hidróxido de sodio. Conducta de emergencia absoluta: Extracción endoscópica inmediata (< 2 horas) bajo anestesia general.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Ante sospecha de cuerpo extraño digestivo: radiografía de cuello, tórax y abdomen siempre
- Cuerpo extraño esofágico: retiro con endoscopia digestiva alta; sialorrea y dolor torácico son los síntomas clave
- Cuerpo extraño post-esofágico de bajo riesgo: observación con control radiológico cada dos semanas
- Pilas, imanes (2 o más), crecimientos y objetos afilados/largos: retiro obligatorio sin importar ubicación
- Comida impactada en esófago: retirar si lleva más de 24 horas, produce dolor o impide deglución de líquidos
- Complicaciones (obstrucción, perforación) del cuerpo extraño post-esofágico: manejo quirúrgico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CUERPO EXTRAÑO DIGESTIVO)

PREGUNTA 1

Niño de 3 años es traído a urgencias porque se tragó una pila botón hace 2 horas. En la radiografía de abdomen se observa la pila a nivel gástrico. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Observación con control radiológico en 2 semanas
- B) Retiro endoscópico del cuerpo extraño
- C) Esperar que sea eliminado en las deposiciones
- D) Administrar laxantes para acelerar el tránsito
- E) Cirugía abdominal de urgencia

PREGUNTA 2

Hombre de 45 años consulta por sensación de cuerpo extraño tras ingerir un trozo grande de carne hace 6 horas. Presenta dolor retroesternal y no puede tragar líquidos. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Observación por 24 horas
- B) Radiografía de tórax y observar
- C) Endoscopia digestiva alta para retiro
- D) Administrar agua carbonatada para desimpactar
- E) TAC de tórax con contraste

PREGUNTA 3

Niño de 5 años se tragó una moneda. En la radiografía se visualiza la moneda a nivel del estómago. Está asintomático. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Endoscopia digestiva alta urgente
- B) Cirugía abdominal
- C) Observación con control radiológico cada 2 semanas
- D) Maniobra de Heimlich
- E) Administrar carbón activado

RESUMEN: CUERPO EXTRAÑO DIGESTIVO

Clase sobre el manejo del cuerpo extraño digestivo. Ante la sospecha, siempre se debe pedir radiografía de cuello, tórax y abdomen. Cuando el cuerpo extraño está en el esófago, se retira con endoscopia digestiva alta; la sialorrea y el dolor torácico (riesgo de perforación y mediastinitis) son los síntomas clínicos clave. Si el cuerpo extraño ya pasó al estómago o intestino y es de bajo riesgo, habitualmente se observa con control radiológico cada dos semanas. Sin embargo, pilas, imanes (dos o más), crecimientos (polímeros absorbentes) y objetos afilados o muy largos (más de 5 cm) deben retirarse independientemente de su ubicación. La comida impactada en el esófago se retira si lleva más de 24 horas, produce dolor o imposibilita la deglución de líquidos. Si está asintomático y puede tragar líquido, se puede observar por 24 horas.